

ПОДРОБНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Клиническое ведение жертв изнасилования и насилия со стороны интимного партнера

WHO, UNFPA and UNHCR · English · 2020

Важно: Это подробное неофициальное руководство по чтению, а не официальный перевод. Обратитесь к исходной публикации для получения полных требований и контекста.

На основе оригинальной публикации

<https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/331535/9789240001411-eng.pdf>

Содержание

1. Цель и сфера применения
2. Ключевые рекомендации
3. Как использовать это руководство
4. Принципы, ориентированные на выжившего
5. Практическая последовательность действий
6. Проверка безопасности и качества
7. Контрольный список действий

01 Цель и сфера применения

- Клинические рекомендации по сострадательной, научно обоснованной помощи после изнасилования и насилия со стороны интимного партнера, включая неотложное лечение, документирование и последующее наблюдение.

02 Ключевые рекомендации

- В первую очередь устраняйте опасные для жизни состояния, сохраняя при этом достоинство, конфиденциальность и контроль пострадавшего над каждым этапом обследования.
- Получите информированное согласие отдельно на обследование, сбор доказательств, лечение, фотографии и обмен информацией; согласие может быть отозвано.
- Предлагайте своевременную профилактику беременности, постконтактную профилактику ВИЧ и уход за инфекциями, передающимися половым путем, в соответствии с действующими национальными протоколами.
- Не проводите тестирование на девственность; оно не имеет научной обоснованности и может причинить физический и психологический вред.
- Используйте обследование с учетом травмы: объясните каждый шаг, сведите к минимуму повторение, при желании позвольте человеку оказать поддержку и остановитесь, когда его об этом попросят.
- Сбор судебно-медицинских доказательств должен осуществляться в соответствии с местным законодательством, правилами цепочки поставок и имеющимися лабораторными возможностями; медицинская помощь никогда не должна зависеть от сбора доказательств.
- Оценивайте психическое здоровье, острый стресс, риск членовредительства и социальные потребности, не патологизируя ожидаемые реакции на травму.
- Запланируйте последующее наблюдение за результатами анализов, вакцинацией, соблюдением режима лечения, беременностью, выздоровлением, психическим здоровьем и безопасным направлением.

Как использовать это руководство

- Это руководство превращает исходную публикацию в практическое пособие для чтения. Он предназначен для лиц, переживших насилие, доверенных лиц, сотрудников медицинских и социальных служб, а также руководителей программ. Он не заменяет службы экстренной помощи, медицинскую помощь, юридическую консультацию или полную публикацию источника.
 - Используйте только те части, которые соответствуют ситуации человека. Сохраните ее выбор, конфиденциальность и темп. Если предлагаемое действие может раскрыть информацию о просмотренных страницах, звонках, документах или местоположении злоумышленнику, сначала выберите более безопасное устройство, место или время.
-

Принципы, ориентированные на выжившего

- Безопасность превыше всего. Спросите, что сделает следующие часы или дни безопаснее, и избегайте шагов, которые могут спровоцировать возмездие. Никогда не требуйте раскрытия информации, чтобы предложить базовую помощь.
- Уважайте автономию и информированное согласие. Объясните реалистичные варианты, преимущества, ограничения и возможные риски; выживший решает, что будет дальше, если не применяется немедленная юридическая обязанность по обеспечению безопасности.
- Защищайте конфиденциальность. Соберите минимум информации, ограничьте доступ, договоритесь о безопасных методах контакта и объясните любые ограничения перед передачей информации.
- Обеспечить равный доступ. Учитывайте инвалидность, язык, возраст, миграционный статус, бедность, сельскую изоляцию, сексуальную ориентацию и другие барьеры без стереотипов.

Практическая последовательность действий

- Начните с неотложных потребностей в области безопасности и неотложных медицинских услуг. Спросите конфиденциально, в отсутствие подозреваемого преступника, безопасно ли разговаривать и нуждается ли человек в неотложной помощи.
- Слушайте без допроса. Подтвердите то, что произошло, избегайте обвинений и не требуйте хронологического отчета или доказательств. Записывайте только то, что необходимо, и используйте собственные слова пострадавшего.
- Предложите небольшое количество проверенных вариантов: медицинскую помощь, безопасное жилье, психосоциальную поддержку, юридическую информацию, полицию или услуги защиты, где это необходимо. Объясните, что принятие одной услуги не требует принятия всех остальных.
- После получения согласия сделайте теплый рекомендацию: подтвердите, что услуга открыта, доступна и безопасна; объяснить, чего ожидать; и избегайте повторной отправки пострадавшего между агентствами.
- Согласуйте дальнейшие действия и безопасный способ общения. Не оставляйте идентифицирующие сообщения, не отправляйте раскрывающие уведомления и не храните файлы под очевидными именами, если за устройствами можно следить.

Проверка безопасности и качества

- Не вступайте в конфронтацию с подозреваемым преступником, не выступайте посредником в отношениях с применением насилия, не обещайте результат, который вы не можете контролировать, и не оказывайте давление на пострадавшего, чтобы тот немедленно ушел.
- Не используйте непроверенные номера телефонов и рекомендации. Службы могут закрыться, изменить правила предоставления услуг или передать информацию небезопасным способом; подтвердите детали перед публикацией или направлением.
- Организации должны обучать персонал, контролировать сложные случаи, создавать правила конфиденциальной документации, обновлять карты направлений и предлагать поддержку персонала, чтобы уменьшить выгорание и вредную практику.

Контрольный список действий

- Безопасно ли сейчас говорить, читать или хранить этот документ?
- Были ли учтены неотложные травмы, проблемы беременности, помощь жертвам сексуального насилия и риск самоубийства?
- Выбрал ли пострадавший, какую информацию можно записывать или передавать?
- Учтены ли барьеры, связанные с устным переводом, доступом для людей с ограниченными возможностями, уходом за детьми, транспортом и ценами?
- Проверены ли направления и существует ли безопасный план последующего наблюдения?
- Сказали ли этому человеку, что насилие не является ее виной и что она может отказаться от любого варианта?